

9. מחלות הלב

⁸⁶(1)

(א) לעניין פרט זה -	
AF - פרפור פרוזדורים (Atrial Fibrillation);	
AR - אי-ספיקה אאורטלית (Aortic Regurgitation);	
AS - הצרות אאורטלית (Aortic Stenosis);	
AVA - שטח המסתם האאורטלי (Aortic Valve Area);	
CRT - קיצוב דו-חדרי לרסינכרוניזציה (Cardiac Resynchronization Therapy);	
CT - בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת;	
EST - מבחן מאמץ (Exercise Stress Test);	
ECHO - בדיקת על-קול גרפיה (אקו לב);	
ECG - רישום פעילות חשמלית לבבית, אלקטרוקרדיו גרם (אקג);	
Holter - מעקב אקג ממושך;	
ICD - קוצב דפיברילטור (Implantable Cardioverter Defibrillator);	
LA - פרוזדור שמאלי (Left Atrium);	
LVEDD - רוחב חדר שמאל בסוף דיאסטולה (Left Ventricular End Diastolic Diameter);	
LVH - התעבות שריר החדר השמאלי (Left Ventricular Hypertrophy);	
LVOT - מוצא החדר השמאלי (Left Ventricular Outflow Tract);	
METS - מדד לעומס מאמץ (Metabolic equivalents);	
MR - אי-ספיקה מיטרלית (Mitral Regurgitation);	
MRI - תהודה מגנטית של הלב;	
MS - הצרות מיטרלית (Mitral Stenosis);	
AVA - שטח המסתם האאורטלי (Aortic Valve Area);	
MVA - שטח המסתם המיטרלי (Mitral Valve Area);	
NYHA - דרגה תפקודית לפי NYHA (New York Heart Association) כמפורט בפרט משנה (ג);	
VT - מהירות חדרית (Ventricular Tachycardia);	
מדג התפקוד על פי NYH	(ב)
טור א' - התסמינים	
I טור ב' - דירוג	
(1) אין הגבלה בפעילות גופנית, פעילות גופנית יום-יומית שגרתית לא גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב	
II (2) הגבלה קלה בפעילות גופנית, הרגשה נוחה במנוחה ובביצוע פעילות יום-יומית שגרתית קלה, פעילות גופנית יותר משגרתית גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב	
III (3) הגבלה ניכרת בפעילות גופנית, הרגשה נוחה במנוחה, פעילות יום-יומית שגרתית כגון הליכה של עד 100 מטרים גורמת לעייפות, פלפיטציות, קוצר נשימה או תעוקת לב	
IV (4) אי-יכולת לבצע פעילות גופנית כלשהי בלא הרגשה לא נוחה; סימני אי-ספיקת לב, גודש ריאתי או סיסטמי, קוצר נשימה ותעוקת לב מופיעים במנוחה וגוברים במאמץ	
מדג מבחן מאמץ (EST), לפי פרוטוקול BRUCE	(ג)
טור א' - קריטריון	
I טור ב' - דירוג	
II יותר מ-9 דקות ($METS > 11$)	
עד 9 דקות ($7 < METS \leq 11$)	

⁸⁶. פרט משנה 1 בפרט 9 הוחלף במלואו בק"ת 7642, התשע"ו, עמ' 966, ת"ת 1.11.16. הוראת התחילה והתחולה קובעות כי התיקון חל על מי שעניינו נדון בוועדה מתאריך התחילה האמור ולאחריו. מי שעניינו נדון בוועדה ערב תאריך התחילה האמור והגיש ערר על החלטת הוועדה לוועדה לערערים, תיקבע דרגת הנכות בהתאם לתקנות העיקריות כנוסחן ערב יום התחילה. נוסחו הקודם של פרט משנה 1 בפרט 9 היה:

(1) במחלת לב שגרונת חריפה, דלקת חידקית, תת-חריפה של פנים הלב (S. B. E.) ובאטם שריר הלב	
(א) בתקופת 3 החדשים הראשונים לאחר גמר ההתקף החריף	100%
(ב) בתקופת 3 החדשים הבאים	50%
(ג) לאחר התקופה הנ"ל יש להעריך בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב -	
(I) מסוגל לעבודה הרגילה ללא הפרעות וללא הגבלות כלשהן	10%
(II) מסוגל לעבודה שאיננה דורשת מאמץ גופני מיוחד (דרגה תפקודית ראשונה)	25%
(III) קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת קלה, אין הפרעות בקצב (דרגה תפקודית שניה)	40%
(IV) קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת עם או בלי הפרעות בקצב כגון: פרפור פרוזדורים התקפי, רפרוף התקפי, מהירות דופק התקפית, מסוגל לעבודה קלה בלבד (דרגה תפקודית שלישית)	50%
(V) קיימת אי-ספיקת הלב במידה בינונית, בצקת, נשמת לאחר מאמץ קל, מסוגל לעבודה קלה ביותר ובישיבה בלבד (דרגה תפקודית רביעית)	75%
(VI) אי-ספיקת לב קשה, אינו מסוגל לשום עבודה	100%

3 עד 6 דקות ($5 \leq \text{METs} \leq 7$)
 פחות מ-3 דקות ($\text{METs} < 5$)
הערה לעניין מבחן מאמץ: במקרים שבהם לא ניתן לבצע בדיקת מאמץ מסיבות שאינן קרדיאליות יש להסתמך על הדרגה התפקודית לפי מדרג ה-NYHA. קביעת הדרגה התפקודית לפי NYHA תיעשה בהתבסס, בין השאר, על בדיקות אקו-דופלר, מיפוי לב פרמקולוגי או בדיקה מקבילה וקביעת אחוזי נכות תיעשה בהתאם.

(ד) רשימת הליקויים:

(1) מחלת לב כלילית (Coronary Artery Disease)
 קביעת דרגת הנכות למחלת לב כלילית עם אוטם שריר הלב המתבטא בתיעוד של אקו, במיפוי לב או ב-ECHO עם אזור ברור, או מחלת לב כלילית עם איסכמיה הפיכה המתבטאת במיפוי לב, ב-ECHO במאמץ, או צנתור עם חסימה מעל - 50% בעורק כלילי, תהיה לפי הטבלה שלהלן:

מדרג מבחן מאמץ / NYHA				
IV	III	II	I	מקטע פליטה לפי בדיקת ה-ECHO
15%	10%	5%	אין נכות	(א) $>60\%$
35%	30%	25%	20%	(ב) 60%-45%
60%	50%	45%	40%	(ג) 44%-30%
100%	90%	80%	70%	(ד) $<30\%$

הערה: המספרים שבשורה המאוזנת והמסומנים בספרות רומיות I עד VI מציינים את הדרגות במדרג מבחן מאמץ על פי פרוטוקול BRUCE או על פי מדרג התפקוד NYHA. האותיות שבטור המאונך א' עד ד' מציינות את מקטע הפליטה על פי בדיקת ה-ECHO. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות לפגימה הנדונה;

(2) מחלת לב מסתמית (Valvular Disease)
 (א)

מדרג מבחן מאמץ / NYHA או קוטר שורש האורטה

IV	III	II	I	רמת הליקוי המסתמי לפי בדיקת ה-ECHO
30%	20%	10%	0	(א) קל
60%	50%	40%	30%	(ב) בינוני
100%	90%	80%	70%	(ג) חמור

הערה: המספרים שבשורה המאוזנת והמסומנים בספרות רומיות I עד IV מציינים את הדרגות במדרג מבחן מאמץ על פי פרוטוקול BRUCE או על פי מדרג התפקוד NYHA. האותיות שבטור המאונך א' עד ג' מציינות את רמת הליקוי המסתמי על פי בדיקת ה-ECHO. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות לפגימה הנדונה.
 (ב) לענין פסקה זו -

רמת הליקוי המסתמי לפי בדיקת ה-ECHO				טור א'
טור ד'	טור ג'	טור ב'	טור א'	
חמור	בינוני	קל		
LVEDD > 65 mm	LVEDD 65-58 mm	LVEDD < 58 mm		אי-ספיקה של המסתם האאורטלי (AR)
LVEDD > 60 mm LA < 50 mm או	LVEDD 60-57 mm LA 40-50 mm או	LVEDD < 57 mm LA < 40 mm או		אי-ספיקה של המסתם המיטרלי (MR)
Peak Gradient > 50 mm Hg או AVA < 1 cm ² או	Peak Gradient 50-25 mm Hg או AVA 1.5-1 cm ²	Peak Gradient < 25 mm Hg או AVA > 1.5 cm ²		היצרות מסתם האאורטלי (AS)
Mean Gradient > 38 mmHg				
Mean Gradient > 10 mm Hg או MVA < 1 cm ² או LA diameter > 50 mmHg	Mean Gradient 10-5 mm Hg או MVA = 1.5-1 cm ²	Mean Gradient < 5 mm Hg או MVA > 1.5 cm ²		היצרות מסתם מיטרלי (MS)

(ג) הערות:

- (1) לעניין אי-ספיקה של המסתם המיטרלי (MR) ניתן להתחשב גם בסימנים אקוקרדיוגרפים מקובלים להגדרת חומרת אי-ספיקה מיטרלית;
- (2) לעניין אי-ספיקה של המסתם האאורטלי (AR) - במצבים שבהם קיימת גם הרחבת שורש האאורטה (Aortic Root Dilatation) - לצורך קביעת דרגת הנכות, ייבחן קוטר שורש האאורטה בשילוב חומרת הליקוי המסתמי לפי בדיקת ה-ECHO כמפורט בטבלה שבפסקת משנה א'; דרגת קוטר האאורטה תהיה כדלקמן:

קוטר שורש האאורטה

טור א' דרגה	טור ב' תיאור	טור ג' קריטריון
I	תקין	< 37mm
II	קל	40mm - 37mm
III	בינוני	45mm - 41mm
IV	חמור	> 45mm

(3) לעניין פסקת משנה (ג) שבטבלה שבפסקת משנה (א) - דרגת הנכות תיקבע לתקופה העולה על 24 חודשים רק במקרים שבהם לא צפוי שינוי במצב הליקוי המסתמי ;

(3) מחלות שריר הלב (Cardiomyopathies) מורחבת (Dilated) (א)

מדרג מבחן מאמץ / NYHA				
IV	III	II	I	מקטע הפליטה לפי ECHO-ה
30%	20%	10%	0	(א) >40%
60%	50%	40%	30%	(ב) 40%-30%
100%	90%	80%	70%	(ג) <30%

הערה: המספרים שבשורה המאוזנת והמסומנים במספרים רומים I עד IV מציינים את הדרגות במדרג מבחן מאמץ על פי פרוטוקול BRUCE או על פי מדרג התפקוד NYHA. האותיות שבטור המאונך א' עד ג' מציינות את מקטע הפליטה על פי בדיקת ה-ECHO. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות לפגימה הנדונה.

(ב) היפרטרופיה ראשונית של שריר הלב (Hypertrophic Cardiomyopathy)		10%
(1) בלא הגבלה תפקודית, או עם הגבלה תפקודית קלה, בלא מפל לחצים במוצא החדר השמאלי (LVOT gradient), בלא עדות להפרעות קצב משמעותיות בהולטר, בלא אי-ספיקה של המסתם המיטרלי (MR), בלא היפרטרופיה משמעותית (עובי דופן פחות מ-13 מ"מ) של חדר שמאל או עם אבחנה ברורה של קרדיומיופתיה אפיקלית		40%
(2) עם הגבלה תפקודית בינונית עם עדות להפרעה דיאסטולית או עם מפל לחצים בינוני ב-ECHO (עד 60 מ"מ כספית) במוצא החדר השמאלי, או פרפור פרוזדורים התקפי, או הפרעות קצב חדירות תכופות או עדות להיפרטרופיה של חדר שמאל ב-ECHO עד 30 מ"מ		100%
(3) הגבלה תפקודית קשה עם הפרעה דיאסטולית קשה או מפל לחצים של יותר מ-60 מ"מ כספית במוצא החדר השמאלי או פרפור פרוזדורים קבוע או התקפים תכופים של פרפור (frequent or persistent AF) או עדות להפרעות קצב חדירות משמעותיות או non-sustained VT (מהירות חדירת לא ממושכת), או היפרטרופיה משמעותית של חדר שמאל - 30 מ"מ ומעלה ב-ECHO		
(ג) רסטורקטיבי (Restrictive)		70%
(1) עם NYHA בדרגה III		100%
(2) עם NYHA בדרגה IV		
(4) דלקת חריפה של קרום הלב או שריר הלב (Pericarditis/Myocarditis)		
דלקת חריפה של קרום הלב או שריר הלב למעט קרדיוטומיה (Cardiotomy), או תסמונת על שם דרסלר (Dressler's Syndrome) וכן למעט מחלות משניות כגון זאבת (Lupus), אורמיה (Uremia) או משנית למחלה ממארת.		
קיומה של דלקת חריפה של קרום הלב או שריר הלב תיקבע בהתבסס על בדיקות CT, ECHO או MRI וכן בהתבסס על שינויי אקג טיפוסיים עם עלייה בסימני הדלקת או עם עדות לתפליט פריקדאלי (יותר ממזער) ב-ECHO או ב-CT או הפרעה אזורית בהתכווצות ב-ECHO או ב-MRI.		
אחוזי הנכות ייקבעו לפי המפורט להלן:		
(א) עם דלקת פעילה, עד 6 חודשים מפרוץ המחלה		100%
(ב) בלא דלקת פעילה או לאחר ריפוי מלא		0%
(ג) בלא דלקת פעילה, עם סמנים המתאימים ל-Chronic constrictive pericarditis וכן		
(1) NYHA בדרגה I		10%
(2) NYHA בדרגה II		25%
(3) NYHA בדרגה III		50%
(4) NYHA בדרגה IV		100%
(5) הפרעות קצב (Arrhythmia)		

קיומן של הפרעות קצב תיקבע על פי בדיקת Holter ל-24 שעות או תיעוד רפואי של אירוע הפרעת קצב. נוסף על כך, נדרשת קליניקה מתאימה, בדיקת תפקוד הלב (למשל ECHO), מבחן מאמץ (EST) או תוצאת צנתור לב. אחוזי הנכות ייקבעו כמפורט להלן:

(א) בהפרעות קצב הנלוות למחלת לב אורגנית הנכות תיקבע לפי המחלה;

- (ב) בהפרעות קצב ראשוניות, לרבות מחלות של תעלות הולכה, מחלות גנטיות, שימוש ב- ICD או CRT, תיקבע דרגת הנכות כמפורט בפרט משנה ד(1);
- (6) לחץ ריאתי מעל 40 מ"מ כ"כ לפי ECHO (Pulmonary Arterial Hypertension) הנובע מליקוי קרדיאלי:
- (א) עם תפקוד לב לא תקין - דרגת הנכות תיקבע על פי המחלה הבסיסית;
- (2) עם תפקוד לב סיסטולי תקין, אך עם עדות להפרעה דיאסטולית חמורה (לא ממחלה ראשונית של עורק הריאה) וכן -
- | | |
|------|--------------------|
| 10% | (א) NYHA בדרגה I |
| 25% | (ב) NYHA בדרגה II |
| 50% | (ג) NYHA בדרגה III |
| 100% | (ד) NYHA בדרגה IV |
- (ב) שאינו נובע מליקוי קרדיאלי - הנכות תיקבע לפי המחלה;
- (7) מחלות לב מולדות (Congenital Heart Disease) דרגת הנכות תיקבע על פי פרט משנה ד(1).

		(בוטל) ⁸⁷ (2)
		(3) יתר לחץ דם
0%	(א) לחץ דם דיאסטולי קבוע שאינו עולה על 95 מ"מ כספית, ללא סימנים אובייקטיביים של פגיעה בלב, בכליות או ברשתיות	
	(ב) לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל ל-95 מ"מ כספית ועד 110 מ"מ כספית:	
***10%	(I) בלי הגדלה ברורה (קלינית, רנטגנית או אלקטרוקרדיוגרפית) של הלב	
30%	(II) עם הגדלה ברורה של הלב, קיימת נשמת בינונית לאחר מאמץ	
	(ג) לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל 110 מ"מ כספית:	
**25%	(I) בלי הגדלה ברורה של הלב ונשמת	
40%	(II) עם הגדלה ברורה של הלב ונשמת בינונית לאחר מאמץ	
	(ד) ⁸⁸ לחץ דם נמוך, או אורתוסטאטי	
0%	(I) בלא סימנים קליניים	
***10%	(II) עם תסמונת אופיינית-	
30%	(1) קלה	
	(2) קשה	
	(בוטל) ⁸⁹ (4)	
	(5) הפרעות מסיבות (N.C.A.) NEUROCIRCULATORY ASTHENIA אחוזי הנכות ייקבעו בתאם להפרעות הנפש.	
	(6) גוף זר בלב ובקרום הלב	
0%	(א) ללא הפרעות	
	(ב) הגורם להפרעות - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.	

⁸⁷ פרט 9 (2) בוטל בק"ת 7642, התשע"ו, עמ' 971, ת"ת 1.11.16. עד לביטולו היה נוסחו:

	(2)'' תעוקת הלב (ANGINA PECTORIS)
25%	(א) התקפים נדירים של תעוקת הלב המופיעים רק במאמץ מיוחד
50%	(ב) התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כושר העבודה מוגבל במידה ניכרת
70%''	(ג) התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כשקיימים כאבים סטנוקרדיים גם במנוחה

הוראת תחילה ותחולה קובעת כי והן יחולו על מי שעניינו נדון בוועדה מיום 1.11.16 (להלן - יום התחילה) ולאחריה. עוד נקבע כי מי שעניינו נדון בוועדה ערב יום התחילה, והגיש ערר על החלטת הוועדה לוועדה לערערים, תיקבע דרגת הנכות בהתאם לתקנות כנוסחן ערב יום התחילה.

⁸⁸ פרט 9 (ד) - נוסף בק"ת 6675 התשס"ח, עמ' 914, ת"ת 1.6.08 בנוסח דלעיל. ראה הוראת תחולה והוראות מעבר בהערות שוליים לפרט א2.

⁸⁹ פרט 9 (4) בוטל בק"ת 7642, התשע"ו, עמ' 971, ת"ת 1.11.16. עד לביטולו היה נוסחו:

	(4)'' הפרעות בקצב
	(א) התקפיים:
***10%	(I) התקפים נדירים
20%	(II) התקפים שכיחים
40%	(III) התקפים שכיחים ביותר
	(ב) קבועים
**20%	(I) ללא סימנים של אי-ספיקת הלב או קיפוח גופני
	(II) קיימת אי-ספיקת הלב, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב
	(ג) מחסום פרוזדורי-חדרי
0%	(I) מחסום חלקי דרגה 1 (PR מאורך)
*10%	(II) מחסום חלקי דרגה 2
50%	(III) מחסום שלם ללא תסמונת ADAMS STOKES
100%''	(IV) מחסום שלם עם התקפי חוסר הכרה (תסמונת ADAMS STOKES)

10. קרום הלב

(בוטל)⁹⁰

11. כלי הדם

		דליות VARICES CRURIS (1)
0%	(א)	ורידים בולטים על הגפיים התחתונות ללא סיבוכים והפרעות
**10%	(ב)	ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, עם התכווצויות וכאבים
**20%	(ג)	ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, ישנם סימני ECZEMA וצלוקות לאחר כיבים שנתרפאו
**30%	(ד)	ורידים המשתרעים על חלק גדול של גפה תחתונה אחת, ישנה נטיה מתמדת לדלקת עור וליצירת כיבים (צורה קשה של ECZEMA (ULCUS VARICOSUM או CRURIS), ללא הפרעות במחזור הוריד העמוק)
**40%	(ה)	המצב כמתואר בסעיף קטן (1) (ד) בשתי הרגליים
50%	(ו)	ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, קיימות הפרעות קשות במחזור הדם הוריד העמוק עם כיבים גדולים ועמוקים ופיגמנטציות על שטח נרחב
	(2)	מצב לאחר נזק בכלי הדם הפריפריים כגון PHLEBITIS או THROMBOPHLEBITIS או נזק בורידים
0%	(א)	קיימת תפיחות קלה, קבועה שאינה גדלה עקב עמידה או הליכה; ישנן הפרעות בלתי ניכרות ברגל אחת
**10%	(ב)	המצב כמתואר בסעיף קטן (2)(א) - בשתי הרגליים
**20%	(ג)	קיימת תפיחות קבועה ניכרת עקב עמידה או הליכה, ישנם PIGMENTATIO וכחלון ברגל אחת
**30%	(ד)	המצב כמתואר בסעיף קטן (2)(ג) - בשתי הרגליים
30%	(ה)	קיימת תפיחות קבועה, קשה שאינה יורדת בזמן המנוחה; ישנם כחלון ECZEMA או כיבים ברגל אחת
40%	(ו)	המצב כמתואר בסעיף קטן (2)(ה) בשתי הרגליים
50%	(ז)	בשתי הרגליים, בצורה קשה מאד
	(3)	מפרצת ANEURYSMA
**10%	(א)	של עורק קטן, בלי הפרעות
**20%	(ב)	של עורק קטן עם הפרעות קלות
**30%	(ג)	של עורק קטן עם הפרעות קשות
40%	(ד)	של עורק גדול בגפיים העליונות עם הפרעות במחזור הדם
50%	(ה)	של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קלות במחזור הדם
60%	(ו)	של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קשות במחזור הדם

⁹⁰ פרט 10 בוטל בק"ת 7642, התשע"ו, עמ' 971, ת"ת 1.11.16. עד לביטולו היה נוסחו:

	(1)"	דלקת קרום הלב נגיפית שפירה או חבלתית
40%	(א)	במשך חדשיים לאחר ההחלמה
	(ב)	לאחר תקופה זו
0%	(I)	התרפאה מבלי להשאיר סימנים קליניים או הפרעות
	(III)	נשארו סימנים קליניים או הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב התפקודי של הלב.
	(2)	דלקת קרום הלב שחפתית
		לאחר ההחלמה הקלינית - אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבע לגבי שחפת ריאות בהתאם לתקופה שלאחר ההחלמה.
		נשארו סימנים קליניים, הפרעות מצד הלב, להעריך בהתאם למצב התפקודי של הלב.
	(3)	CONSTRUCTIVE PERICARDITIS ודלקת קרום הלב שגרונית
	(א)	בהתאם למצב התפקודי של הלב
	(ב)	במקרה של ניתוח
60%	(I)	במשך 6 החדשים הראשונים לאחר הניתוח
	(III)	לאחר תקופה זו, בהתאם למצב התפקודי של הלב."

הוראת תחילה ותחולה קובעת כי והן יחולו על מי שעניינו נדון בוועדה מיום 1.11.16 (להלן - יום התחילה) ולאחריו. עוד נקבע כי מי שעניינו נדון בוועדה ערב יום התחילה, והגיש ערר על החלטת הוועדה לוועדה לערערים, תיקבע דרגת הנכות בהתאם לתקנות כנוסחן ערב יום התחילה.

60%	(ז) של אב העורקים בבית החזה או בבטן, ללא הפרעות קשות או מצב אחרי ניתוח של ANEURYSMA כנ"ל	
100%	(ח) של אב העורקים, בבית החזה או בבטן, עם הפרעות קשות	(4)
	ARTERIO - VENOUS FISTULA	
	אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (3).	
	M. RAYNAUD ENDARTERITIS OBLITERANS	(5)
	(M. BUERGER)	
**20%	(א) בצורה קלה ברגל אחת	
**30%	(ב) בצורה קלה בשתי הרגליים	
40%	(ג) בצורה בינונית ברגל אחת	
50%	(ד) בצורה בינונית בשתי הרגליים	
60%	(ה) בצורה קשה	
100%	(ו) בצורה קשה מאד	
	נזקי כפור ברגליים	(6)
**0%	(א) קיימים סימנים קלים בלבד - בועות כפור (CHILLBLAINS)	
	(ב) קיימת תפיחות מתמדת בצורה בינונית, כאבים, אודם וכד':	
**5%	(I) בגף אחד	
**10%	(II) בשני הגפיים	
	(ג) עם איבוד אצבעות הרגליים או חלקים מהן, ייקבעו אחוזי הנכות לקטיעות האצבעות	

12. מערכת העיכול

(1) לשון (נמחק)⁹¹

	(2) ושט	
	(א) מיצר STRICTURA של הושט -	
30%	(I) בצורה בינונית	
50%	(II) בצורה קשה	
80%	(III) בצורה קשה מאד, המאפשרת רק שתיית נוזלים, מצב כללי ירוד מאד	
	(ב) סעיפי הושט (DIVERTICULUM):	
0%	(I) ללא הפרעות או עם הפרעות קלות	
10%	(II) הפרעות בינוניות	
30%	(III) הפרעות קשות	
	(ג) אזופגיטיס (ESOPHAGITIS):	
**10%	(I) בצורה קלה	
30%	(II) בצורה בינונית	
50%	(III) בצורה קשה עם שטפי דם חוזרים, אנמיה בולטת	
	(ד) קרדיוספזמוס (CARDIOSPASM):	
	(I) אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב הכללי ולדרגת היצרות של הושט	
0%	(II) לאחר ניתוח, אין הפרעות	
	(III) לאחר ניתוח, קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ג.	
	(ה) בקע סרעפתי (HERNIA DIAPHRAGMATICA)	
	(א) אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב של הושט בהתאם לסעיף קטן ג.	
	(ב) בקע סרעפתי לאחר ניתוח:	
0%	(I) אין הפרעות	
	(II) קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ג	
	(3) קיבה	
	(א) דלקת כרונית של הקיבה:	
**0%	(I) בצורה קלה ללא הפרעות	
**10%	(II) בצורה בינונית: המצב הכללי והתזונתי משביע רצון	

⁹¹ בק"ת 7584, התשע"ו, עמ' 286, ת"ת 1.7.16 נמחק פרט 12(1). נוסחו היה:

"(1) לשון

(א) איבוד פחות ממחצית הלשון:

10% (I) ללא השפעה בולטת על הדיבור והבליעה

20% (II) עם השפעה בולטת על הדיבור והבליעה

(ב) איבוד מחצית הלשון או יותר מכן:

40% (I) ללא איבוד מוחלט של הדיבור והבליעה

"60% (II) עם איבוד מוחלט של הדיבור והפרעה ניכרת בבליעה

ראו הוראות תחילה ותחולה לתיקון התשע"ו בסוף הערת השוליים לפרט משנה 3(1) לחלק א' לתוספת.